Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
11ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre

Rua Manoelito de Ornelas, 50 - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90110230 - Fone: (51) 3210-6500 - Email: frpoacent11vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5212541-31.2023.8.21.0001/RS

AUTOR: MARINA RUSCHEL PEREIRA PY

RÉU: BRADESCO SAUDE S/A

SENTENÇA

VISTOS.

Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por **MARINA RUSCHEL PEREIRA PY** em face de **BRADESCO SAUDE S/A** alegando ser cliente dos serviços da operadora de plano de saúde ré e que recebeu o diagnóstico de esclerose múltipla há cerca de um ano do ajuizamento da ação, além de prescrição médica para o tratamento com o fármaco NATALIZUMABE 300 mg, cuja cobertura foi negada pela requerida, em 30/09/2023. Aduziu que o tratamento possui custo expressivo e alegou que a recusa de cobertura é ilegal, citando a proteção conferida ao consumidor pelo CDC. Discorreu sobre os danos morais experimentados em face da negativa. Frisou que a necessidade é urgente, citando o art. 35-C da Lei dos planos de saúde. Em sede de tutela de urgência, requereu a condenação da ré ao fornecimento do fármaco. Ao final, requereu a confirmação da liminar concessiva do medicamento Natalizumabe 300 mg e condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00. Juntou documentos.

Deferida a liminar para a determinar à ré que forneça à parte autora a cobertura do medicamento Natalizumabe 300mg, conforme o laudo médico.

Devidamente citada, a requerida ofereceu contestação arguindo preliminar de impugnação ao valor da causa. No mérito, sustentou que o contrato está adaptado à legislação de plano de saúde e sujeito às limitações de cobertura. Afirmou que o caso da autora não preenche as diretrizes de utilização para a concessão do fármaco postulado, já que está na primeira linha de tratamento. Aduziu a expressa exclusão de cobertura. Discorreu sobre o posicionamento da jurisprudência e sobre a taxatividade do rol da ANS. Postulou a improcedência do pedido. Juntou documentos.

Houve réplica.

Em saneamento, afastada a preliminar e registrada a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

Após intimação, não houve pedido de dilação probatória.

Vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A solução da demanda independe de outras provas, incidindo, por consequência, o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015. Afigura-se, pois, dispensável a dilação probatória, sendo, ademais, medida que atende aos princípios de economia processual e da celeridade da justiça.

Trata-se de ação cominatória pela qual a parte autora pretende seja a requerida obrigada a fornecer o medicamento Natalizumabe 300mg, na qualidade de operadora do plano de saúde contratado.

Nessa linha, inegável a aplicabilidade das disposições do Código de Defesa do Consumidor e dos princípios que norteiam as relações de consumo, disposições que devem ser aplicadas em conjunto com o regramento especial dos plano de saúde (Lei n° 9.656/98).

A autora é cliente dos serviços prestados pela ré, enquadrando-se no conceito de consumidor, nos moldes do artigo 2.º da Lei nº 8.078/90. A parte ré, por seu turno, na condição de prestadora de serviços de seguro saúde, enquadra-se no conceito de fornecedora, nos termos do artigo 3.º, do mesmo diploma legal.

Aliás, tal questão restou sedimentada, a partir da edição da Súmula 60/STJ, que assim dirimiu a controvérsia:

> ***"Súmula 608:*** *Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de planode saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão."*

No caso dos autos, é incontroversa a relação jurídica mantida entre as partes e o diagnóstico de Esclerose Múltipla, bem como a prescrição médica para uso do fármaco Natalizumabe 300mg.

Com isso, a discussão restringe-se à regularidade da negativa de custeio do procedimento, sob o argumento de que seria inviável o tratamento do paciente com o medicamento, diante do não preenchimento da diretriz de utilização n. 65 da Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS.

Ilustro a comunicação enviada pela ré (evento 1.12):

Em resposta à solicitação de V.Sa. e em cumprimento ao parágrafo 1º, do artigo 10º, da Resolução Normativa nº 395/2016, editada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que dispõe sobre as regras a serem observadas pelas Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde nas solicitações de procedimentos e/ou serviços de cobertura assistencial apresentados pelos beneficiários, em qualquer modalidade de contratação, cumpre informar a impossibilidade em atender a cobertura pleiteada, uma vez que o(s) procedimento(s) reivindicado(s) consta(m) no Rol de Procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), quando atendida a diretriz de utilização descrita abaixo, disposta na Resolução Normativa nº 465, que entrou em vigor a partir de 01/04/2021.

65. TERAPIA IMUNOBIOLÓGICA ENDOVENOSA, INTRAMUSCULAR OU SUBCUTÂNEA (COM DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO)

Ocorre que a tese de defesa não é suficiente para justificar a negativa administrativa.

Cumpre dizer que a Lei n. 9.656/98 estabeleceu o plano referência de assistência à saúde, estipulando coberturas mínimas a serem fornecidas pela operadora do plano, conforme rol do art. 12 da Lei n. 9.656/98, e coberturas passíveis de ampliação, mas sem cobertura obrigatória, que encontra disposição no art. 10 do mesmo diploma, conforme segue:

"Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental;

II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim;

III - inseminação artificial;

IV - tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética;

V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados;

VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar;

VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico;

IX - tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou não reconhecidos pelas autoridades competentes;

X - casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela autoridade competente."

"Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1ºdesta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

I - quando incluir atendimento ambulatorial:

a) cobertura de consultas médicas, em número ilimitado, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina;

b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente;

c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes;

d) cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da evolução da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do médico assistente, realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar;

e) cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais utilizados, assim como da remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro estabelecimento hospitalar, dentro dos limites de abrangência geográfica previstos no contrato, em território brasileiro; e

f) cobertura de despesas de acompanhante, no caso de pacientes menores de dezoito anos;

g)cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar;

III - quando incluir atendimento obstétrico:

a) cobertura assistencial ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor, ou de seu dependente, durante os primeiros trinta dias após o parto;

b) inscrição assegurada ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor, como dependente, isento do cumprimento dos períodos de carência, desde que a inscrição ocorra no prazo máximo de trinta dias do nascimento ou da adoção;
(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

IV - quando incluir atendimento odontológico:

a) cobertura de consultas e exames auxiliares ou complementares, solicitados pelo odontólogo assistente;

b) cobertura de procedimentos preventivos, de dentística e endodontia;

c) cobertura de cirurgias orais menores, assim consideradas as realizadas em ambiente ambulatorial e sem anestesia geral;

V - quando fixar períodos de carência:

a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo;

b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos;

c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência;

VI - reembolso, em todos os tipos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras, de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega da documentação adequada;

VII - inscrição de filho adotivo, menor de doze anos de idade, aproveitando os períodos de carência já cumpridos pelo consumidor adotante."

Conforme artigo 10, § 4.°, da Lei n. 9.656/1998, cabe à ANS a divulgação de rol de eventos em saúde que são de cobertura obrigatória pelas operadoras de plano de saúde, ao que se denomina de rol da ANS, estipulado na Normativa n. 428/2017, atual RN nº 465/2021-ANS.

Outrossim, a partir do julgamento do EREsps n. 1.889.704/SP e 1.886.929/SP, pelo Relator Min. Luis Felipe Salomão, julgados perante a 2.ª Seção da Corte de Justiça, em 08/06/2022, entendeu-se que o rol de eventos em saúde divulgado pela ANS seria taxativo.

Entretanto, ao lado da jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça no sentido da taxatividade do rol de eventos em saúde divulgado pela ANS conforme determinação do art. 10, § 4.°, da Lei n. 9.656/1998, **coexiste** o regime legal disciplinado pela Lei n. 14.454/2022, que alterou parcialmente a disposição do artigo 10 da Lei n. 9.656/1998, no sentido de autorizar a superação do rol de eventos em saúde a partir de bases confiáveis de eficácia do tratamento/exame/medicamento *verbis*:

"Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

(...)

§ 4º A amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será estabelecida em norma editada pela ANS, que publicará rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado a cada incorporação.

(...)

*§ 12. O **rol** de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.*

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais." (NR) ***(grifei)***

Outrossim, o próprio STJ deixa claro a possibilidade excepcional de cobertura do procedimento indicado pelo médico mas não previsto no rol da agência reguladora, inexistindo substituto terapêutico listado, desde que "*(I) não tenha sido indeferida expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (II) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (III) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (IV) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.*" (AgInt no REsp n. 2.058.219/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.)

Insta consignar, ainda, que a recusa simplesmente baseada no não preenchimento da Diretriz de Utilização não prospera, já tendo o Min. Raúl Araújo registrado que "***a recusa de cobertura com base somente na ausência de enquadramento nas diretrizes de utilização da ANS para o tratamento (...), sem a indicação, em contrapartida, de terapêutica alternativa eficaz e segura para a enfermidade que acomete o paciente, afigura-se abusiva, aplicando-se aqui a mesma ratio dos medicamentos off label***" (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.031.610/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.).

À luz dessas diretrizes, denota-se que o rol da ANS estipula a cobertura obrigatória do medicamento nos seguintes casos:

"65.13 ESCLEROSE MÚLTIPLA

1. Cobertura obrigatória do medicamento Natalizumabe para pacientes com Esclerose Múltipla Recorrente-Remitente grave em rápida evolução, definida por 2 ou mais recidivas incapacitantes no espaço de um ano e com 1 ou mais lesões realçadas por gadolínio em uma imagem do cérebro obtida por Ressonância Magnética Nuclear (RMN) ou um aumento significativo das lesões em T2 comparativamente com uma RMN anterior recente.

2. Cobertura obrigatória do medicamento Natalizumabe, quando preenchidos todos os critérios do Grupo I e nenhum dos critérios do grupo II. Após o início do tratamento a cobertura não será mais obrigatória caso o paciente apresente um dos critérios do Grupo III:

Grupo I

a. Diagnóstico de Esclerose Múltipla (EM) pelos Critérios de McDonald revisados e adaptados;

b. Esclerose Múltipla Recorrente Remitente (EM-RR) ou Esclerose Múltipla Secundariamente progressiva (EM - SP);

c. Lesões desmielinizantes à Ressonância Magnética;

d. Diagnóstico diferencial com exclusão de outras causas;

e. Em terceira ou quarta linha de tratamento quando houver falha terapêutica ou resposta sub-ótima, intolerância, eventos adversos ou falta de adesão na primeira e segunda linha, no mínimo.

Linhas de tratamento:

• Primeira linha: betainterferona, glatirâmer ou teriflunomida.

• Segunda linha: betainterferona, glatirâmer, teriflunomida, fumarato de dimetila ou fingolimode.

• Terceira linha: fingolimode. O uso do Natalizumabe em terceira linha somente será indicado caso o Fingolimode tenha sido prescrito em segunda linha ou caso haja contra-indicação ao seu uso.

f. Estar sem receber imunomodulador por pelo menos 45 dias ou azatioprina por 3 meses;

g. Ser encaminhado a infectologista ou pneumologista para afastar tuberculose se apresentarem lesões suspeitas à radiografia de tórax;

h. Valores de neutrófilos acima de 1.500/mm3 e linfócitos acima de 1.000/mm3 ao hemograma.

Grupo II

a. Diagnóstico de Esclerose Múltipla Primariamente Progressiva (EM-PP) ou de EMPP com surto.

b. Incapacidade de adesão ao tratamento e impossibilidade de monitorização dos efeitos adversos;

c. Intolerância ou hipersensibilidade ao medicamento;

d. Diagnóstico de leucoencefalopatia multifocal progressiva (LEMP);

e. Pacientes que apresentem qualquer uma das seguintes condições: micose sistêmica nos últimos 6 meses, herpes grave ou outras infecções oportunistas nos últimos 3 meses, infecção por HIV, imunossupressão, infecção atual ativa;

f. Pacientes com câncer, exceto se carcinoma basocelular de pele.

Grupo III

a. Surgimento de efeitos adversos intoleráveis após considerar todas as medidas atenuantes;

b. Falha terapêutica definida como dois ou mais surtos no período de 12 meses, de caráter moderado ou grave (com sequelas ou limitações significantes, pouco responsivas à pulsoterapia) ou evolução em 1 ponto na escala Expanded Disability Status Scale (EDSS) ou progressão significativa de lesões em atividade da doença."

Na hipótese, a requerida reconhece o enquadramento da autora no item 2 acima mencionado, mas contesta o preenchimento de todos os requisitos do Grupo I, em especial a utilização do fármaco como terceira linha de tratamento.

Contudo, é de se ressaltar que a prescrição do médico que acompanha a paciente possui indicação expressa de que a autora possui contraindicação "*com exclusão racional de diagnósticos alternativos*"(evento 1.10), circunstância que autoriza a relativização das exigências técnicas.

No mesmo sentido já se posicionou o TJRS:

APELAÇÕES CÍVEIS. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESCLEROSE MÚLTIPLA. MEDICAMENTO NATALIZUMABE. TRATAMENTO INTRAVENOSO. NEGATIVA DE COBERTURA. COBERTURA DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RETORNO DO STJ. NOVO JULGAMENTO. 1. O DEVER DE FORNECIMENTO DO TRATAMENTO MÉDICO COM NATALIZUMABE PARA A MOLÉSTIA DIAGNOSTICADA NA PARTE AUTORA ESTÁ PREVISTO NO ROL DE COBERTURAS MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS DA ANS. 2. HIPÓTESE EM QUE A PARTE AUTORA FOI DIAGNOSTICADA COM ESCLEROSE MÚLTIPLA REMITENTE RECORRENTE EM ALTA ATIVIDADE, COM RISCO DE MORTE, SITUAÇÃO QUE AUTORIZA A RELATIVIZAÇÃO DA DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO Nº 65 DA RN 465/2021. 3. AINDA QUE POR FUNDAMENTOS DIVERSOS, É CASO DE MANUTENÇÃO DO DEVER DE COBERTURA FIXADO NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO E, POR CONSEQUÊNCIA, DO DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO DESPROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ E PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR, EM NOVO JULGAMENTO. (Apelação Cível, Nº 50283208520208210010, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 25-10-2023)

A ré, por sua vez, não produziu prova em contrário a fim de demonstrar que seria viável a prescrição de tratamento alternativo, ônus que lhe competia, conforme art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ainda, consigno que há robusta corroboração clínica ao uso do medicamento em pareceres do NATJUS, cabendo ressaltar, nesse sentido, as conclusões contidas nas Notas Técnicas n. 205910[1], de 22/03/2024, e n. 205910[2], de 18/09/2023, sendo este último desenvolvido pelo Departamento Médico Judiciário deste Tribunal.

Dito isso, impõe-se confirmar a tutela de urgência que reconheceu o dever de cobertura ao medicamento prescrito pelo médico da paciente.

Com relação aos danos morais, também com razão a parte autora.

Cediço que o mero inadimplemento contratual não é suficiente a ocasionar danos de ordem moral, ressalvada hipóteses excepcionais devidamente comprovadas.

Contudo, é iterativa a jurisprudência no sentido de que a recusa indevida a procedimento/exame pelo plano de saúde é causa suficiente a caracterizar abalo moral.

Cito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER (CITORREDUÇÃO CIRÚRGICA COM QUIMIOTERAPIA INTRAPERITONEAL CHEMOTERAPY). RECUSA ABUSIVA. PRECEDENTES DO STJ. DANOS MORAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. VALOR. RAZOABILIDAE E PROPORCIONALIDADE.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, o rol de procedimentos editado pela ANS não pode ser considerado meramente exemplificativo. Contudo, a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol não se aplica à análise do dever de cobertura de medicamentos/procedimentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS.
2. No caso, trata-se de procedimentos para tratamento de câncer (citorredução cirúrgica com quimioterapia intraperitoneal "Chemoterapy"), hipótese em que a jurisprudência é assente no sentido de que o fornecimento é obrigatório. Precedentes.
3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "a recusa injustificada de cobertura de tratamento de saúde enseja danos morais em razão do agravamento da aflição e angústia do segurado que já se encontra com sua higidez físico-psicológica comprometida em virtude da enfermidade"(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.963.420/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022).
4. Hipótese em que o Tribunal de origem concluiu pela existência de danos morais indenizáveis. Alterar esse entendimento demandaria o reexame de provas, inviável em recurso especial por esbarrar no óbice da Súmula n. 7/STJ.
5. Não se mostra exorbitante o quantum indenizatório fixado pelo TJPE em R$ 20.000,00.
Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.102.534/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.) (grifei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. RESILIÇÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO AO USUÁRIO. AUSÊNCIA. TRATAMENTO DE URGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. CABIMENTO. REVISÃO. REEXAME. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ.
1. Tratam os autos da discussão acerca da responsabilidade da administradora do plano de saúde coletivo empresarial pela resilição unilateral do contrato sem prévia notificação ao segurado durante o tratamento de urgência ou de emergência e o cabimento de indenização por danos morais.
2. Não viola o artigo 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta.
3. A jurisprudência desta Corte Superior preleciona que é abusiva a rescisão unilateral sem que a operadora do plano de saúde proceda à notificação prévia do usuário.
4. O mero descumprimento contratual não enseja indenização por danos morais. Na hipótese de recusa de cobertura pela operadora de saúde nos casos de tratamento de urgência ou emergência, o entendimento desta Corte é de que há configuração de danos morais indenizáveis.
5. Na caso, o acórdão estadual, amparado no acervo fático-probatório dos autos, reconheceu o ato ilícito praticado pela operadora de saúde, apto a ensejar o dever de indenizar, o que atrai a incidência da Súmula nº 7/STJ.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.142.481/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. COBERTURA NEGADA. COPARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. DANOS MORAIS.
1. Nos contratos de plano de saúde não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, à razão máxima de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, nos casos de internação superior a 30 (trinta) dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, preservada a manutenção do equilíbrio financeiro (Tema Repetitivo nº 1.032).
2. Na hipótese, rever a conclusão das instâncias ordinárias, que asseveraram que a cláusula de coparticipação em internações psiquiátricas não foi contratada pelas partes, de modo que a cobrança não poderia ser realizada pela operadora de plano de saúde, encontra óbice nas Súmulas nºs 5 e 7/STJ.
3. A recusa indevida, pela operadora de plano de saúde, de autorizar tratamento médico de urgência ou de emergência enseja reparação a título de danos morais, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.831.676/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)

Dito isso, entende-se que a recusa indevida a tratamento de doença grave é suficiente a alcançar a esfera da personalidade do paciente, causando-lhe angústias, aflições e desequilíbrio psicológico oriundo da incerteza acerca de seu tratamento e da preservação de sua saúde.

Corroborando:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO CONDENATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. ADITAMENTO CONTRATUAL PARA ADAPTAÇÃO À LEI Nº 9.656/1998 NÃO IMPUGNADA. RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA À LUZ DA LEI DOS PLANOS DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. DEVER DE COBERTURA DE TRATAMENTO DE CÂNCER VERIFICADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS NO CASO CONCRETO. 1) Em que pese o contrato de plano de saúde do qual o autor era beneficiário originalmente não fosse regulamento à Lei nº 9.656/1998, a parte requerida nada esclareceu acerca do documento relativo ao aditamento contratual noticiado na inicial, não se desincumbindo do ônus da impugnação específica, que impõe ao réu rebater específica e pontualmente todas as alegações feitas pelo autor, fundamentando suas alegações, sob pena de ser considerado o fato não impugnado como incontroverso. 2) Embora por fundamentos diversos, correta a resolução da controvérsia à luz da Lei nº 9.656/1998, tal como procedeu o juízo de origem. 3) Não prospera o argumento de que o procedimento prescrito ao autor não existia na data da assinatura do contrato (1998) e que o pacto não previa a sua cobertura, na medida em que, na forma do aditamento contratual não impugnado, as partes resolveram, de comum acordo, acrescentar coberturas ao seu plano de saúde, sem limitação, dentre as quais está presente o tratamento de câncer. 4) A negativa de cobertura do procedimento de "ablação por radiofrequência", sob o fundamento apresentado - ausência de previsão contratual - afigurou-se abusiva, o que justifica a condenação do réu imposta na sentença, para ressarcir os custos do procedimento negado e reparar os danos morais sofridos. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO.(Apelação Cível, Nº 50001415320208210007, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 27-07-2023)

No que diz respeito ao *quantum* indenizatório, tem-se, como regra geral, a outorga ao juiz de poderes amplos para o arbitramento do valor, contando ele, no respectivo exercício, com certas fórmulas que lhe servem de apoio para a ministração da justiça.

Nesse diapasão, são critérios de remuneração do dano: a gravidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração das consequências, a condição econômica do ofensor de suportar a indenização, além do caráter didático e pedagógico, todos em observância à Tese n° 01 da Edição 125 de Responsabilidade Civil, editada recentemente pelo STJ[3].

Sopesando as características do ilícito, em especial, o fato de a negativa ter ocorrido em 30/09/2023 e a concessão da medida em 09/10/2023, denotando diminuto lapso de tempo sem acesso ao tratamento, tenho que o montante de **R$ 4.000,00** se mostra justo e adequado para reparar o prejuízo experimentado, sem ensejar o ilícito enriquecimento da parte, atendendo ao caráter pedagógico e dissuasório da medida.

Observando o mesmo patamar indenizatório:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CÂNCER DE PULMÃO. MEDICAMENTO ATEZOLIZUMABE 1200MG EV (TECENTRIQ). COBERTURA OBRIGATÓRIA. RN 465/2021. DANOS MORAIS DESCABIMENTO . RELATOR VENCIDO, NO PONTO 1) Trata-se de ação de obrigação de fazer, combinada com indenizatória, através da qual a parte autora postula coberturada da medicação Atezolizumabe 1200mg EV (Tecentriq) para o tratamento de câncer de pulmão (CID 10 C34), julgada parcialmente procedente, na origem. 2) A Lei nº 14.454/22, estabeleceu novos critérios para permitir a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estejam incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, utilizando dois parâmetros semelhantes aos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para excepcionar a taxatividade do rol (EREsp 1886929 e EREsp nº 1889704). 3) Das condicionantes fixadas pela Corte Superior para excepcionar o Rol da ANS, remanescem as constantes nos itens "ii" e "iii" - (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; e (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros. 4) Segundo entendimento do egrégio STJ, é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. 5) No caso em comento, o autor é portador de câncer de pulmão (CID 10 C34), nos termos do laudo médico acostado no Evento 3, PROCJUDIC2, necessitando tratamento quimioterápico, urgente, com a medicação denominada Atezolizumabe 1200mg EV (Tecentriq), que foi negada pela requrida sob o argumento de que o pedido administrativo não foi concluído em razão da não apresentação de documentação complementar necessário para a cobertura do medicamento. 6) Sem razão a negativa de cobertura pela apelante, pois o tratamento prescrito é de cobertura obrigatória, conforme se extrai da leitura do artigo 18, inciso XI da Resolução Normativa n. 465/2021. Precedentes do STJ. 7) A injusta recusa de cobertura de seguro saúde, que, no caso dos autos, se manifesta pela evidente situação de urgência/emergência apresentada pelo autor que estava gravemente doente, tanto que veio a falecer no curso do processo, dá direito ao segurado ao ressarcimento dos danos extrapatrimoniais sofridos. Precedentes do egrégio STJ. 8) A indenização por dano moral não deve ser irrisória, de modo a fomentar a recidiva, pois não se pode esquecer que o "quantum" reparatório deve ser apto a ser sentido como uma sanção pelo ato ilícito, sem que, contudo, represente enriquecimento ilícito à vítima. Valorando-se as peculiaridades da hipótese concreta e os parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência para a fixação de indenização, em hipóteses símiles, fixo em R$ 5.000,00 (...) o valor da indenização. Relator vencido, no ponto. DUPLA APELAÇÃO. APELOS DESPROVIDOS, VENCIDO O RELATOR QUE DAVA PROVIMENTO AO APELO DA PARTE AUTORA (Apelação Cível, Nº 50009799620188212001, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 10-11-2023)

Tratando-se de indenização por dano moral, a correção monetária incide da data do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ. Os juros moratórios, por sua vez, incidem a partir da citação, ante a responsabilidade contratual da ré.

Ainda, a teor da Súmula 326 do STJ, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica em sucumbência para a parte autora.

Nessa conjuntura, a procedência da demanda é medida que se impõe.

DIANTE DO EXPOSTO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo ***PROCEDENTES*** os pedidos formulados por **MARINA RUSCHEL PEREIRA PY** em face de **BRADESCO SAUDE S/A** para:

A) CONFIRMAR a tutela de urgência concedida liminarmente para **DETERMINAR** à ré que forneça à parte autora a cobertura do medicamento Natalizumabe 300mg, conforme o laudo médico; e

B) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00, com correção monetária pelo IGP-M a contar desta decisão e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios ao procurador do autor, os quais fixo em 20% sobre o valor atualizado da condenação em danos morais, nos termos do artigo 85, § 2.º, do CPC, considerando a natureza da causa e o trabalho desenvolvido.

Havendo interposição de apelação no prazo recursal, intime-se o apelado, para, querendo, oferecer contrarrazões. Após, nada mais ensejando intervenção do juízo de primeiro grau, remeta-se ao TJRS. Do mesmo modo, na hipótese de interposição de apelação adesiva, vista à parte contrária para apresentação de contrarrazões, no prazo legal, sendo, após, remetido ao TJRS.

Não havendo interposição de recurso certifique-se o trânsito em julgado e, uma vez recolhidas eventuais custas, arquive-se com baixa.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Documento assinado eletronicamente por **CINTIA DOSSIN BIGOLIN, Juíza de Direito**, em 27/4/2024, às 18:18:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10058088416v12** e o código CRC **252c91c5**.

---

1. Disponível em: <https://pje.jus.br/e-natjus/notaTecnica-dados.php?output=pdf&token=nt:205910:1712695794:e14c219d017614def1522780a4ece4f176e95e52d978b672f9de7f4202c957f9> ↩
2. Disponível em: <https://pje.jus.br/e-natjus/notaTecnica-dados.php?output=pdf&token=nt:163803:1712695794:c5bb8ab82c87ade776cac04dec4e37b7b582f545da148b874e82ffb5433d8279> ↩
3. "A fixação do valor devido à título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano. ↩